



Universidad Nacional
Federico Villarreal

VRIN | VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN

FACULTAD DE MEDICINA “HIPÓLITO UNANUE”
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO

ACCESO EN SALUD Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA EN
USUARIOS REFERIDOS AL CENTRO DE SALUD MENTAL
COMUNITARIO MANGOMARCA, 2025

Línea de investigación:

Salud pública

Para optar el Grado Académico de Maestro en Gestión y Conducción en Salud

Autor:

Vilchez Lavado, Harold Claesen

<https://orcid.org/0009-0007-6143-133X>

Asesor:

Dr. Cruz Gonzales William Enrique

<https://orcid.org/0000-0002-1655-5671>

Jurado

Apellidos, Nombres

Lima - Perú

2025

Autor:

Vilchez Lavado, Harold Claesen

Índice

Carátula	i
Autor:	ii
Índice.....	iii
I. Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema.....	2
1.2. Descripción del problema	3
1.3. Formulación del problema	4
1.4. Antecedentes	5
1.5. Justificación de la investigación	9
1.6. Limitaciones de la investigación.....	11
1.7. Hipótesis	12
II. Marco teórico	13
2.1. Marco conceptual.....	13
III. Método	19
3.1. Tipo de investigación.....	19
3.2. Población y muestra.....	19
3.3. Operacionalización de variables	21
3.4. Instrumentos.....	23
3.5. Procedimientos.....	26
3.6. Análisis de datos	27
3.7. Consideraciones éticas	28
IV. Aspectos administrativos	29
4.1. Cronograma de actividades.....	29
4.2. Presupuesto de la investigación	29

4.3. Fuentes de financiamiento	29
V. Referencias.....	30
VI. Anexos	36
Anexo 1. Matriz de consistencia.....	36
Anexo 2. Instrumento de recolección de datos	37
Anexo 3. Consentimiento informado.....	43

I. Introducción

El acceso a los servicios de salud se construye a partir de múltiples factores que interactúan entre sí, incluyendo las condiciones individuales, familiares, el entorno social y físico, así como la forma en que están organizados los sistemas de salud, sus instituciones y los propios prestadores del servicio (Vértiz-Ramírez et al., 2024). El acceso a los servicios de influye directamente en cómo las personas perciben su propio estado de salud y en su calidad de vida. Esta relación se hace más evidente en aquellos con condiciones de salud más delicadas y puede variar según el entorno en el que se encuentren (Zhang et al., 2019).

Entre los distintos factores que influyen en la calidad de vida, el acceso oportuno a la atención médica juega un papel fundamental. Contar con servicios de salud accesibles permite identificar y tratar problemas de salud a tiempo, lo que mejora el bienestar general. Además, facilita el seguimiento médico, el uso adecuado de medicamentos y el acceso a recursos comunitarios que promueven la autonomía y previenen complicaciones (Royce et al., 2024). Diversos estudios han evidenciado que la facilidad para acceder a los servicios de salud influye positivamente en el estado de salud de la población. En particular, se ha observado que la atención brindada en centros comunitarios enfocada en la prevención y manejo temprano de enfermedades, puede generar mejoras sostenidas en la salud y en la calidad de vida de los pacientes, incluso en contextos de recursos limitados (Wang et al., 2023; Vértiz-Ramírez et al., 2024).

Por ello, esta investigación aportó evidencia sobre la relación entre el acceso a los servicios de salud mental y calidad de vida de los usuarios en un entorno urbano específico. Permitió identificar barreras y facilitadores dentro del sistema de salud, contribuyendo al diseño de estrategias orientadas a mejorar la equidad y eficacia en la atención. Los resultados contribuyeron a la optimización de los procesos del Centro de Salud Mental Comunitario Mangomarca, facilitando así la toma de decisiones, la asignación adecuada de recursos y la implementación de mejoras centradas en las necesidades de la población.

1.1. Planteamiento del problema

El acceso a la atención sanitaria influye significativamente en la salud a lo largo de la vida de la vida de las personas. El acceso adecuado permite una detección temprana de enfermedades, lo que facilita intervenciones proactivas que mejoran al manejo de afecciones y la esperanza de vida. Aunque muchos sistemas de salud buscan reducir las barreras de acceso, diversos obstáculos aún dificultan este propósito (Coombs et al., 2021).

Globalmente, uno de cada 8 personas sufre de alguna enfermedad mental; sin embargo, aspectos como la falta de infraestructura especializada, inaccesibilidad geográfica o los altos costos de atención dificultan que estas personas accedan a los servicios de salud mental. Además, el estigma social y el miedo a la discriminación llevan a muchas personas a evitar buscar ayuda, perpetuando así el sufrimiento y la exclusión (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2023). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), desde incluso antes de la pandemia por COVID-19, alrededor del 70% de las personas no tiene acceso a una atención en salud mental eficaz, asequible y de calidad, con una brecha especialmente marcada en países de ingresos bajos.

A nivel internacional, un estudio realizado en población de Grecia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos, reportó que el 19,8% de los encuestados experimentó un acceso insuficiente a la atención sanitaria (Alezxandrov et al., 2024). Otro estudio reportó que el 95,6% de los adultos enfrentó al menos una barrera para acceder a los servicios médicos, siendo el costo de la atención la principal preocupación (Coombs et al., 2021).

Existen otras barreras documentadas que limitan el acceso a la salud, como el desconocimiento sobre dónde buscar ayuda, largos tiempo de espera, escasez de profesionales, falta de supervisión gubernamental, barreras culturales y lingüísticas, estigma, inequidades

geográficas-demográficas, dificultades laborales, y costos elevados no cubiertos por seguros (Moroz et al., 2020; Bogart et al., 2022).

Esta falta de acceso en salud podría afectar la salud y el bienestar general de las personas, es decir, mermar su calidad de vida (Alezxandrov et al., 2024). Esto se debe a que tienen menos probabilidad de recibir atención médica oportuna, acceder a terapias y obtener recomendaciones sobre estilos de vida que podrían proteger su salud (Erskine et al., 2019). En esta línea, un estudio realizado por Wang et al. (2023), revelaron que los pacientes con dificultades para acceder a la atención médica mostraron una calidad de vida relacionada con la salud significativamente menor ($p < 0,001$), en comparación con aquellos que tuvieron un acceso más fácil a los servicios de atención primaria. Por su parte, Carandang et al. (2024) reportaron que el acceso a la atención sanitaria se relaciona positivamente con una mejor calidad de vida general. Además, influye en distintos aspectos de la calidad de vida, como la salud física, la salud psicológica, el entorno de vida y las relaciones sociales.

No obstante, la evidencia aún no es contundente, ya que otra investigación no encontró una relación significativa entre el acceso a la atención médica y la calidad de vida relacionada a la salud (Alezxandrov et al., 2024), lo que sugiere la necesidad de seguir explorando esta asociación en diferentes contextos.

1.2. Descripción del problema

A nivel nacional, un estudio realizado en un hospital de Cajamarca encontró que el acceso a los servicios de salud era mayormente de nivel medio (71,3%), al igual que la calidad de vida reportada por los pacientes con discapacidad (68,8%). Además, se identificó una relación significativa entre ambas variables ($p = 0,000$) (Castillo, 2024). A pesar de estos hallazgos, aún no hay evidencia concluyente que confirme si esta relación se mantiene en el contexto de los centros que brindan atención de salud mental, pues los estudios mencionados se realizaron en otros ámbitos. Por lo descrito, es necesario realizar investigaciones específicas

para comprender mejor cómo el acceso a los servicios mencionados impacta en el bienestar de los usuarios.

En el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se ubica el Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, el acceso en salud se ve limitado por características propias de la población (pobreza, lejanía, falta de seguro médico, estigmatización) así como por la propia institución (alta demanda y recursos insuficientes); empero, se desconoce la influencia de aquello en la calidad de vida de los usuarios referidos al centro de salud mencionado. En tal línea, se cree pertinente la ejecución de la presente investigación.

1.3. Formulación del problema

Problema General

¿Cuál es la relación entre el acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025?

Problemas Específicos

¿Cuál es la relación entre la dimensión geográfica del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025?

¿Cuál es la relación entre la dimensión organizacional del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025?

¿Cuál es la relación entre la dimensión sociocultural del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025?

¿Cuál es la relación entre la dimensión económica del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025?

¿Cuál es la relación entre el acceso en salud y la calidad de vida, ajustada a variables sociodemográficas y clínicas en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025?

1.4. Antecedentes

1.4.1 Antecedentes Internacionales

Osongo et al. (2024), en Kenia, desarrollaron un estudio con el objetivo de evaluar el efecto del acceso a los cuidados de la salud en la calidad de vida en adultos con discapacidades. Fue una metodología de casos y controles en donde incluyeron a 212 personas. Se concluye que, el acceso a los servicios de salud está relacionado con la calidad de vida de las personas y con las discapacidades que estas puedan tener. El principal resultado observado fue que el acceso a la salud estuvo relacionado con la calidad de vida de las personas ($p < 0,05$) y aquellos que tenían discapacidades se encontraban con mayores límites en el acceso, por lo cual tenían una calidad de vida más baja ($p < 0,05$).

Royce et al. (2024), en Filipinas, desarrollaron un estudio con el objetivo de estudiar la asociación entre el acceso a la salud y la calidad de vida de adultos mayores de la comunidad. Fue una metodología transversal en donde se involucraron a 410 personas. Se concluye que, el acceso a la salud mejora en grandes medidas la calidad de vida de los adultos en las comunidades, especialmente en cuestión a la accesibilidad y asequibilidad. Encontraron dentro de los resultados que, el acceso a la salud fue alto (promedio 120,13) y la calidad de vida moderada (promedio 70,79). Se encontró una asociación significativa entre el acceso a la salud general y la calidad de vida general de las personas ($\beta = 0,22$; 95%IC 0,10-0,33).

Ann et al. (2024), en Estados Unidos, desarrollaron un estudio con el objetivo de evaluar la asociación entre la percepción de acceso inadecuado al cuidado y la calidad de vida en salud de los pacientes con esclerosis múltiple. Fue un estudio transversal en donde se incluyeron a 4 914 pacientes. Se concluye que, las barreras en el acceso al cuidado en salud afectan en gran proporción a la calidad de vida de las personas, por lo cual, el acceso a la salud debería ser una prioridad en el sistema de salud. Encontraron que los pacientes que reportaron tener la necesidad de ver a un proveedor de salud, pero no tenían acceso o veían a un proveedor,

pero les hubiera gustado más seguido tuvieron una calidad de vida más baja que aquellos que tuvieron la oportunidad de ver a un proveedor cada que lo necesiten ($p<0,05$).

Vértiz-Ramírez et al. (2024), en México, en su estudio con el objetivo de identificar las diferencias de las barreras de acceso a servicios de salud en personas con y sin vulnerabilidad. Fue una metodología transversal en donde se incluyeron a 20 018 personas. Se concluye que, la satisfacción de la persona se basa en el acceso completo de los servicios de salud y mejora la calidad de vida mientras se reduce la vulnerabilidad de esta población. Se encontraron barreras para el acceso de salud principalmente personales y organizacionales y la población con mayor vulnerabilidad tuvo barreras económicas y personales. Así también se encontró una diferencia significativa entre las barreras de acceso según tipo de vulnerabilidad ($p<0,05$).

Alexandrov et al. (2024), en Países Bajos, desarrollaron un estudio con el objetivo de determinar si el acceso a la salud estuvo asociado con la calidad de vida de las personas durante la pandemia de COVID-19. Fue una metodología longitudinal en donde se incluyeron a 6 765 personas. Se concluye que, la calidad de vida puede estar influenciada por el acceso a los servicios de salud en las personas, pero no por características propias como edad o sexo. Se obtuvo como resultado que el 19,5% tuvieron un insuficiente acceso a los servicios de salud y aquellos que tenían este problema tenían una calidad de vida más baja comparado con los que sí tuvieron un suficiente acceso; sin embargo, no se identificó una relación significativa entre la edad, el género y las enfermedades crónicas ($p>0,05$).

Al Sayigh et al. (2023), en Arabia Saudita, realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la calidad de vida entre adultos con anemia drepanocítica. Fue una metodología transversal en donde se incluyeron a 272 pacientes. Se concluye que, la calidad de vida está relacionada con diferentes factores entre los cuales está el acceso a la salud. Se encontró que el mayor puntaje en el instrumento de la calidad de vida fue en la dimensión social (65 puntos), mientras que la más baja fue en la salud física (47,2 puntos). De los encuestados, el 29,6%

tuvieron una buena accesibilidad a los servicios de salud, mientras que el 43% identificó debilidades en la comunicación de los profesionales de salud.

Adusei y Adjei. (2023), en Ghana, desarrollaron un estudio con el objetivo de evaluar la relación entre la capital social, el acceso a los servicios de salud y la calidad de vida relacionada a la salud en residentes urbanos. Fue una metodología transversal en donde involucraron a 1 233 adultos. Se concluye que, el acceso a la salud y la capital social son medios importantes para una mejora en la calidad de vida de las personas. Encontraron que, el 24,1% tuvieron un bajo acceso a la salud, el 41,8% calificaba su salud como promedio y el 10,1% como pobre. Se determinó que el acceso a los servicios de salud ($\beta=0,777$; $p < 0,001$) y la capital social ($\beta=0,281$; $p < 0,01$) estuvieron relacionados con la calidad de vida en salud de los participantes.

Wang et al. (2023), en China, realizaron un estudio con el objetivo de medir el porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas que tuvieron fácilmente el manejo para estas enfermedades y su asociación con la calidad de vida. Fue una metodología transversal en donde se incluyeron a 5 535 pacientes. Se concluye que, el acceso a los diferentes tipos de servicios de salud mejora la calidad de vida de los pacientes. Se encontró que, el 24,3% identificó un acceso definitivo a los servicios mientras que un 45,9% fue sencillo. Además, se encontró que el acceso a estos servicios de manejo para las enfermedades se asoció positivamente a una mayor calidad de vida ($p < 0,05$).

Houghton et al. (2022), en América Latina, desarrollaron un estudio con el objetivo de determinar la relación entre las barreras de acceso informativo y la utilización de los servicios esencial en mujeres, niños y niñas. Fue una metodología transversal en donde se incluyeron a 141 862 personas. Se concluye que, las barreras para el acceso al servicio de salud influyen en las atenciones necesarias de acuerdo con la etapa de vida; así mismo, puede influenciar directamente con la calidad de vida de esta población. Se encontró que las barreras geográficas

(36,6%) y financieras (61,8% en mujeres de 35 a 49 años y 52,5% en mujeres de 15 a 18 años) redujo en gran cantidad la probabilidad de completar las atenciones prenatales y un parto asistido, así mismo se disminuyeron la probabilidad de realizarse un Papanicolau o completar las vacunas en los niños, entre otras atenciones.

Choojaturu et al. (2019), en Tailandia, desarrollaron un estudio con el objetivo de evaluar los factores asociados al acceso a los servicios de salud y la calidad de vida de los pacientes con osteoartritis de rodilla. Fue una metodología transversal en donde se involucraron a 618 pacientes. Se concluye que el acceso a la salud no está relacionado con la mejora de la calidad de vida del paciente. Encontraron como resultados que, la calidad de vida de los pacientes fue pobre (puntaje promedio de 33,8) y solo el 2,1% de los pacientes tuvieron una accesibilidad fácil a los cuidados que necesitaban. En el análisis multivariado se encontró que, el acceso a los servicios de salud se relacionaba con la autogestión ($p=0,01$), pero no con la calidad de vida ($p>0,05$).

1.4.2 Antecedentes Nacionales

Ypanaque (2024), en Perú, realizó un estudio con el objetivo de determinar las barreras de acceso a los servicios de salud primarios de salud sexual y reproductiva en adolescentes. Fue una metodología de casos y control donde se incluyeron a 288 adolescentes. Se concluye que existen barreras económicas, demográficas y geográficas que afectan al acceso a los servicios de salud y esto puede influenciar en la calidad de vida de los adolescentes. Se encontró como resultado que la edad, el sexo y el aspecto financiero se relacionó con el acceso a los servicios de salud ($p<0,01$). La economía y el factor geográfico también se identificó como una barrera de acceso ($OR=4,23$; $p < 0,05$).

Castillo (2024), en Cajamarca, realizó un trabajo de investigación con el objetivo de determinar la relación entre el acceso a los servicios de salud y la calidad de vida en los pacientes con discapacidad. Fue una metodología transversal en donde se incluyeron a 80

pacientes. Se concluye que, el acceso a los servicios de salud en las personas con discapacidad influye significativamente en la calidad de vida de los mismo. Se encontró que, el 63,7% de las personas tuvieron un acceso nivel medio y el 67,5% tuvo una calidad de vida media. Hubo una correlación entre ambas variables (Pearson=0.751; $p<0,05$).

Pezo et al. (2023), en Perú, realizaron un estudio con el objetivo de diagnosticar el acceso a los servicios de salud gineco-obstétrica en los establecimientos penitenciarios. Fue una metodología transversal en donde se incluyeron a 13 establecimientos penitenciarios. Se concluye que el acceso a los servicios de salud en esta población es limitado lo cual podría afectar en la calidad de vida de las mujeres debido a la mayor vulnerabilidad que se les impone. Se encontró que el 34,09% cuentan con los servicios mencionados mientras que el 65,91% no lo tienen, lo cual podría perjudicar en su salud.

Rivera-Lozada et al. (2020), en Lima, realizaron un estudio con el objetivo de evaluar las barreras de acceso a los servicios de atención en salud y la adherencia en pacientes con tuberculosis. Fue una metodología mixta en donde se incluyeron a 120 pacientes. Se concluye que existen barreras en el acceso a los servicios de salud que impiden la adherencia al tratamiento de la enfermedad, lo cual influye directamente en la calidad de vida de las personas. Se encontró como resultado que, las barreras encontradas fueron en las dimensiones de aceptabilidad, contacto y disponibilidad. Además, se encontró una asociación entre la adherencia al tratamiento e indicadores como vergüenza de atenderse, desconfianza en el equipo de salud, percepción de mala calidad de atención y falta de concientización sobre la enfermedad ($p<0,05$).

1.5. Justificación de la investigación

A nivel teórico, el estudio aporta datos específicos sobre la relación entre el acceso a los servicios de salud mental y la calidad de vida de los pacientes, en un contexto determinado. Ello puede generar evidencia sobre barreras y facilitadores en el sistema de salud, ayudando a

mejorar estrategias de atención vinculadas con la eficacia y la equidad del sistema de salud, además, aporta a la literatura científica sobre salud pública y salud mental comunitaria en contextos urbanos pudiendo identificar las características de la población que pueden intervenir en su calidad de vida. Por otra parte, la investigación puede servir como base para futuras exploraciones en otras instituciones o a nivel multicéntrico, en donde se podrán evaluar distintas áreas, esto podrá ser de ayuda para que se proporcionen políticas y prácticas en la misma nación, así como en otros países similares.

Este estudio está alineado con el objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Salud y Bienestar, específicamente en la meta 3.4, que busca reducir en un tercio la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la salud mental y el bienestar, ya que, las enfermedades mentales pueden incrementar el riesgo de complicar las enfermedades ya existentes, lo que emporra la tasa de morbilidad en el país. Al contar con un mejor acceso a los servicios de salud se podrá brindar una atención más especializada y de calidad que pueda mejorar las tasas. También se vincula con la meta 3.8, que promueve la cobertura universal de salud, incluyendo acceso a servicios de salud esenciales de calidad.

A nivel práctico, el estudio puede contribuir a que los usuarios del establecimiento estudiado obtengan un mejor acceso a tratamientos oportunos y de calidad beneficiando en su salud con el control y tratamiento de las enfermedades; además, se podrán identificar las barreras que se presenta en esta población que limita el acceso a la salud con la finalidad de tomar medidas para lograr una mayor cobertura de atención. Asimismo, permite dar voz a los usuarios para que sus necesidades sean escuchadas en la mejora de los servicios de salud.

Los profesionales de la salud podrán utilizar los hallazgos para ajustar sus estrategias de intervención en salud mental como capacitaciones o implementar enfoques centrados en la mejora de la calidad de vida de los usuarios y sensibilizar sobre las barreras de acceso y generar

soluciones prácticas que se acomoden a la situación actual del paciente tanto en el aspecto social, económico y cultural.

Finalmente, los resultados del estudio pueden ser utilizados por el Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca para mejorar sus procesos de atención, optimizar la distribución de recursos y justificar la necesidad de mayor financiamiento y personal, así pues, se podrán identificar las debilidades de cada área de atención y aquellas en las que los pacientes tienen mayor problemas de acceso, para que se puedan mejorar mediante diferentes estrategias como implementar mayores horarios de atención o visitas domiciliarias. También pueden ayudar a identificar poblaciones vulnerables y diseñar programas específicos para mejorar su acceso a los servicios en base a sus necesidades.

1.6. Limitaciones de la investigación

Una de las limitaciones más importantes de esta investigación es la imposibilidad de establecer causalidad, ya que se utilizará un diseño correlacional. Este tipo de estudio no permite determinar la direccionalidad de la relación, lo que incrementa la posibilidad de que exista un tercer factor no observado que influya en los resultados. Por ello, se ha decidido ajustar la relación en función de las características sociodemográficas y laborales que podrían tener impacto en la correspondencia, según la evidencia científica.

Así mismo, al trabajar con datos auto informados, será posible incurrir en fuentes potenciales de sesgo, como la memoria selectiva, efecto telescopio, atribución y exageración, lo que pocas veces puede ser verificado de forma independiente. Por esa razón, se hará especial énfasis en el anonimato, pues ha demostrado ser un factor crucial para fomentar la honestidad y minimizar los sesgos relacionados a preocupaciones sobre la privacidad o consecuencias por parte del nosocomio.

Los resultados no podrán ser extrapolados a otras poblaciones o contextos, ya que solo representarán a los usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca.

Esta limitación, debe considerarse una oportunidad para fomentar la ejecución de investigaciones estructuradas bajo el mismo enfoque temático, cotejar hallazgos y avanzar colectivamente hacia una solución.

1.7. Hipótesis

Hi: La relación entre el acceso en salud y la calidad de vida es directa y significativa en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025.

Ho: La relación entre el acceso en salud y la calidad de vida no es directa y significativa en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025.

II. Marco teórico

2.1. Marco conceptual

2.1.1 Acceso en salud

El acceso se puede definir como la forma de acercarse a un lugar o el derecho a usar algo; sin embargo, con el tiempo distintos autores han interpretado la palabra de diferente manera mencionando que es el ajuste de las necesidades del paciente y la capacidad del mismo sistema de poder ofrecerlas. Otro autor la define como la cantidad de la población que recibe atención eficaz, mientras que otros, lo definen como la capacidad de la población de usar la atención médica (De Tapia et al., 2024).

Pese a las diferentes definiciones que se le ha brindado al acceso a la salud, es importante conocer que todas conllevan al beneficio del paciente y esta debe ser brindada en todas las etapas de la atención. En primer lugar, durante la percepción de la necesidad, en segundo en la búsqueda de atención, en tercero en el alcance de la atención, en cuarto en la utilización de la atención y en quinto en la consecuencia de la atención (De Tapia et al., 2024).

El acceso a la salud es un derecho fundamental de todo ser humano en donde debe recibir atención médica oportuna, además de las atenciones por emergencia cuando se requiera sin la necesidad de solicitar algún documento previo a la atención. Por otro lado, dentro del acceso a la salud se encuentran los servicios de información en donde los pacientes pueden obtener información clara y precisa sobre los diferentes servicios que se ofrece. El adecuado acceso a la información podrá ser favorable para que los pacientes tengan en conocimiento la utilidad de cada servicio y así se eviten barreras de acceso (Gobierno del Perú, 2024).

La accesibilidad es un componente básico de los servicios de salud ya que se tiene que asegurar que todos los bienes y servicios disponibles se encuentren en acceso para todos los pacientes independientemente sea su condición. Esta accesibilidad presenta dimensiones las

cuales son la discriminación, accesibilidad física, económica y de información. Es importante que las personas con discapacidades tengan acceso a la salud en todas sus dimensiones; para ello, es necesario evaluar las barreras para este acceso dentro de las cuales se distinguen las físicas, geográficas, económicas y de otro rubro (OMS, 2023).

En nuestro país ya se cuenta con una cobertura amplia de algún seguro de salud; por tanto, es indispensable que se otorgue un acceso completo a estos pacientes y una buena calidad de atención. Estos puntos representan uno de los primeros y más importantes desafíos en la administración y gestión de cada institución de salud (Defensoría del pueblo, 2024).

Debido a la pandemia por el COVID-19, se implementó la telemedicina, con la finalidad de que todas las personas tengan acceso a los diferentes servicios de salud y así no descuiden su calidad de vida ni mucho menos se agraven patologías ya existentes. Con esta situación, se crearon resoluciones y directivas como la resolución ministerial N° 242-2024/MINSA o la directiva administrativa N° 355-MINSA/DGAIN-2024, las cuales orientan al uso de los servicios de salud mediante la tecnología (Ministerio de Salud [MINSA], 2024).

2.1.1.1 Barreras de acceso en Salud. Las barreras de acceso a la salud son la principal causa para que la población no acuda a tiempo a utilizar los diferentes tipos de atención. Estas barreras se presentan en diferentes formas como factores económicos, sociales y culturales, además también se encuentran factores propios del sistema de salud como los organizacionales. El no resolver estas barreras puede incrementar el riesgo de morbilidad y mortalidad que pueden ser evitadas a tiempo afectando la calidad de vida de la población, especialmente la más vulnerable (OPS, 2023).

Durante la pandemia del COVID-19, estas barreras fueron en ascenso ya que no se presentaba disponibilidad total para la atención de otras enfermedades para ese momento, dado que cerraron diferentes servicios con la finalidad de priorizar las atenciones COVID. En este contexto, se estudiaron las barreras que afectaban al acceso a la salud demostrando que, estas

no eran similares entre los países. Por ejemplo, en Colombia y Perú, las barreras más importantes fueron de aceptabilidad, mientras que en Honduras fue la barrera financiera (OPS, 2023).

El objetivo de todo país y de toda institución es la inexistencia de barreras en el acceso a la salud y la equidad en todos los servicios, la intención es que todos tengan un acceso libre y universal a los servicios de salud; sin embargo, se presentan distintas barreras que repercuten en este objetivo y, por tanto, en la satisfacción y bienestar de los ciudadanos. Las barreras de acceso en muchas ocasiones es debido a la desigualdad que existe en el país y esto se refleja en la percepción de la mala calidad de atención, por ello, todo gobierno y todo país, tiene como objetivo fundamental erradicar estas barreras en beneficio de su población (Bazualdo y Contreras, 2022).

2.1.1.2 Medición del acceso a la salud. Para medir el acceso a los servicios de salud se presenta el modelo de Levesque, el cual establece las diferentes barreras en la atención en salud, esto con la finalidad de identificar las necesidades específicas de cada persona, aunque, este modelo fue utilizado en adultos mayores, es importante extrapolarlo a otras poblaciones para evaluar el acceso en las diferentes etapas de atención y así contribuir con la satisfacción del usuario (OPS, 2023).

2.1.1.3 Dimensiones. Son las siguientes

A. Económica: Esta dimensión evalúa el impacto económico que requiere el acceso a la salud, como el gasto en transporte y la accesibilidad económica que representa (Carrasco., 2024).

B. Geográfico: En esta dimensión evalúa la distancia que se requiere para llegar al centro de salud o el hospital, el transporte y el tiempo necesario que necesitará el paciente (Carrasco., 2024).

C. Organizacional: En esta dimensión se evalúa la disponibilidad de los recursos físicos con los que se cuenta para la atención, así como también los recursos humanos. Por otro lado, se evalúa el tiempo de espera, la calidad de atención y la percepción de la atención que tiene el paciente (Carrasco., 2024).

D. Sociocultural: En esta última dimensión, abarcará sobre la aceptabilidad que tiene el paciente para una correcta atención así también como la percepción del trato que ellos presentan frente al profesional de salud (Carrasco., 2024).

2.1.2 Calidad de vida

La calidad de vida se relaciona con diferentes rubros como la economía, psicología, sociología y salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida hace referencia a la percepción personal de su posición en la vida en un contexto del sistema cultural y de los valores, además de estar relacionado con los objetivos, normas y preocupaciones; por tanto, la calidad de vida es algo subjetivo ya que dependerá de cada persona (Robledo et al., 2022; Ruíz-Prieto y López-Medina, 2023).

Por otro lado, la calidad de vida se genera debido a la interacción de factores objetivos como subjetivos de la propia persona en donde influyen otros factores como los económicos, culturales y ambientales que estarán en relación con el desarrollo del ser humano y de su personalidad (Robledo et al., 2022).

2.1.2.1 Medición de la calidad de vida. Para la medición de la calidad de vida, distintas organizaciones han desarrollado instrumentos de evaluación. Estas evaluaciones se desarrollan desde los años 70, en donde abordan temas como el bienestar psicológico, en salud, social, económico y político (Ramírez-Coronel et al., 2020); sin embargo, el instrumento de WHOQOL-BREF desarrollado por la Organización Mundial de la salud, es el indicado para esta investigación.

El WHOQOL-BREF es un instrumento que cuenta con 26 preguntas diferenciadas en 4 dimensiones, la salud física, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. Cada dimensión tiene una puntuación del 1 al 5, entendiendo que a mayor puntuación mejor calidad de vida tienen (Ortiz y Martínez, 2021).

2.1.2.2 Dimensiones. Son las siguientes:

A. Salud física: En esta dimensión se evalúa el nivel físico del paciente como las actividades que se realiza diariamente, la dependencia de sustancias medicinales, la energía o fatiga que presentan, la movilidad y el dolor o incomodidad al momento de realizar una actividad, el descanso y sueño y la capacidad para trabajar (Cutipa y Zamora., 2020).

B. Salud mental: En la dimensión de salud mental se evalúa la imagen corporal y la percepción del mismo paciente frente a esta, los sentimientos negativos y positivos que presentan, la autoestima, la religión o las creencias individuales, el aprendizaje, la memoria o la concentración (Cutipa y Zamora., 2020).

C. Relaciones sociales: En las relaciones sociales se evalúa las relaciones personales, el apoyo social que presenta el paciente y la actividad sexual (Cutipa y Zamora., 2020).

D. Entorno. Finalmente, en el entorno o medio ambiente se evalúa los recursos económicos, la protección, asistencia social, el entorno doméstico, la oportunidad de adquirir conocimiento o de realizar actividades recreativas, el entorno físico y la movilidad que presenta el paciente (Cutipa y Zamora., 2020).

2.1.3 Acceso a la salud y su relación con la calidad de vida

Se ha demostrado que el acceso a la salud es un factor fundamental para el bienestar integral del paciente, ya que no solo favorece la posibilidad de recibir atenciones médicas oportunas, sino que también garantiza el acceso a una amplia gama de servicios de salud esenciales. Además, permite recibir orientación profesional que impulsa la adopción de hábitos de vida saludables, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la salud a largo plazo. Un

acceso adecuado a la salud es, por tanto, un pilar clave para prevenir complicaciones y promover el bienestar general. Ante esta realidad, un acceso limitado o deficiente a estos servicios representa una amenaza seria que puede comprometer significativamente la salud y la vida del paciente (Erskine et al., 2019).

Diversos estudios han evidenciado esta relación, como los realizados por Wang et al. (2023) y Carandang et al. (2024), los cuales destacan que una calidad de vida óptima está estrechamente vinculada a un adecuado acceso a la atención en salud. Estos estudios subrayan cómo el acceso oportuno y adecuado a servicios médicos influye directamente en la mejora del bienestar general, la prevención de enfermedades y la adopción de hábitos de vida saludables, contribuyendo así a un nivel de vida más alto y saludable para los pacientes.

III.Método

3.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación será observacional, correlacional y transversal.

Observacional, porque el investigador se limitará únicamente a observar los fenómenos en su ambiente natural, sin manipular deliberadamente las variables (Hernández y Mendoza, 2018).

Correlacional, porque el objetivo del estudio es analizar la relación entre dos variables (Hernández y Mendoza, 2018).

Transversal, porque los datos serán recolectados en un tiempo único (Hernández y Mendoza, 2018).

3.2. Población y muestra

3.2.1 Población

250 usuarios externos referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, durante el periodo abril-agosto del 2025.

3.2.1.1 Criterios de selección

A. Criterios de inclusión. Usuarios externos de ambos sexos y de 18 años o más. Usuarios externos referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, desde otros establecimientos de salud, como el MINSA, EsSalud, sanidad policial, etc. Usuarios externos atendidos entre abril y agosto del 2025. Usuarios externos que acepten participar en el estudio, mediante la firma de un consentimiento informado.

B. Criterios de exclusión. Usuarios externos con trastornos mentales graves, como trastorno psicótico, trastorno bipolar en fase maníaca o depresiva grave, trastorno de la personalidad límite o antisocial, trastorno del espectro autista en fase severa y trastornos de ansiedad grave, como la agorafobia. Usuarios externos con trastornos del procesamiento

sensorial. Usuarios externos con trastornos neucognitivos, como la demencia y Alzheimer. Usuarios externos con trastornos relacionados al abuso de sustancias, como dependencia y abuso de alcohol o drogas. Usuarios externos con afasia. Usuarios externos analfabetas. Usuarios externos que hablen un idioma diferente al español. Usuarios externos que no completen la totalidad del cuestionario. Usuarios externos que revoquen su participación.

3.2.2 Muestra

Uso de fórmula para población finita.

$$n = \frac{N * Z_{1-\alpha/2}^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_{1-\alpha/2}^2 * p * q}$$

Parámetros:

$N = 250$: Usuarios externos referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, durante el periodo abril-agosto del 2025.

$Z_{1-\alpha/2} = 1.96$: Nivel de confianza de 95%.

$p = 0.50$: Proporción de pacientes con alto acceso en salud y alta calidad de vida.

$q = 1 - p = 0.50$: Proporción de pacientes con medio-bajo acceso en salud y moderado-baja calidad de vida.

$d = 0.05$: Error de precisión.

$n = 152$: Tamaño de la muestra.

Muestra, 152 usuarios externos referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, durante el periodo abril-agosto del 2025.

3.2.2.1 Tipo y técnica de muestreo. El tipo de muestreo será probabilístico y aleatorio simple.

3.3. Operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICIÓN OPERATIVA	DIMENSIONES	ITEMS	INDICADOR DE CALIFICACIÓN	TIPO DE VARIABLE	ESCALA DE MEDICIÓN	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Acceso en salud	Capacidad de los usuarios externos en condición de referidos para obtener servicios de salud oportunos, adecuados y de calidad, en ausencia de barreras asociadas a la disponibilidad, accesibilidad, adaptación, asequibilidad y aceptabilidad.	Geográfica	22, 23, 24, 25, 26, 27	Bajo (<11 puntos) Medio (11-16 puntos) Alto (>16 puntos)	Cualitativa	Ordinal	Cuestionario para medir el acceso a la salud
		Organizacional	1, 2, 3, 4	Bajo (<23 puntos) Medio (23-35 puntos) Alto (>35 puntos)			
		Sociocultural	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13	Bajo (<21 puntos) Medio (21-31 puntos) Alto (>31 puntos)			
		Económica	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Bajo (<16 puntos) Medio (16-23 puntos) Alto (>23 puntos)			
		Salud física	3, 4, 10, 15, 16, 17, 18	Baja (6-14 puntos) Moderada (15-25 puntos) Alta (26-35 puntos)			
Calidad de vida	Percepción de los usuarios externos en condición de referidos sobre su bienestar físico y mental, así como de diversos aspectos de su vida: apoyo social, relaciones personales, recursos financieros, cuidado social, seguridad y recreación.	Salud psicológica	5, 6, 7, 11, 19, 26	Baja (6-14 puntos) Moderada (15-23 puntos) Alta (24-30 puntos)	Cualitativa	Ordinal	Cuestionario de calidad de vida WHOQOL BREF
		Relaciones sociales	20, 21, 22	Baja (3-6 puntos) Moderada (7-10 puntos) Alta (11-15 puntos)			
		Ambiente	8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25	Bajo (8-18 puntos) Moderado (19-28 puntos) Alto (29-30 puntos)			
Edad	Periodo transcurrido entre el nacimiento de los usuarios externos en condición de referidos y el momento de la recolección de datos.			Años	Cuantitativa	Razón	
Sexo	Condición biológica que etiqueta a los usuarios externos en condición de referidos como varones o mujeres.	No aplica	No aplica	Femenino Masculino	Cualitativa	Nominal	Cuestionario
Estado civil	Condición jurídica que define la situación de pareja de los usuarios externos en condición de referidos.			Soltero (a) Casado (a) Conviviente Divorciado (a)	Cualitativa	Nominal	

Viudo (a)				
Grado de instrucción	Nivel más alto de estudios realizados o en curso de los usuarios externos en condición de referidos.	Primaria Secundaria Superior técnico Superior universitario Estudiante Ama de casa	Cualitativa	Ordinal
Condición laboral	Situación o estatus de los usuarios externos en condición de referidos, respecto a su vínculo laboral o empleo.	Trabajador independiente Trabajador dependiente Desempleado Jubilación tramitada	Cualitativa	Nominal
Ingresos Económicos	Cantidad de dinero que perciben mensualmente los usuarios externos en condición de referidos.	< 1130 soles 1130-2500 soles >2500 soles	Cualitativa	Ordinal
Condición de fumador	Usuarios externos en condición de referidos que han fumado diariamente durante el último mes cualquier cantidad de cigarrillos, incluso uno.	Si No	Cualitativa	Nominal
Trastornos psicológicos o psiquiátricos	Conjunto de afecciones que alteran el estado de ánimo, pensamiento o comportamiento de los usuarios externos en condición de referidos.	Trastorno de ansiedad generalizada Trastornos del estado de ánimo Trastornos del sueño Otros Ninguna	Cualitativa	Nominal
Comorbilidades médicas	Presencia de una o más enfermedades, además de la patología primaria.	Hipertensión arterial Diabetes mellitus Enfermedad cardíaca Otras	Cualitativa	Nominal

3.4. Instrumentos

La técnica de recolección de datos será la encuesta y el instrumento un cuestionario, conformado por las siguientes secciones:

3.4.1 Sección I: Características sociodemográficas y clínicas

En esta sección se incluirá información sobre la edad (años), sexo (femenino, masculino), estado civil (soltero, casado, conviviente, divorciado, viudo), grado de instrucción (primaria, secundaria, superior técnico, superior universitario), condición laboral (estudiante, ama de casa, trabajador independiente, trabajador dependiente, desempleado, jubilación tramitada), ingresos económicos (<1130 soles, 1130-2500 soles, >2500 soles), condición de fumador (sí, no), trastornos psicológicos o psiquiátricos (trastorno de ansiedad generalizada, trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño, otros) y comorbilidades médicas (ninguna, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca, otras).

3.4.2 Sección II: Acceso en salud

Esta variable será medida mediante el cuestionario de acceso a la salud de Carrasco (2024) (Anexo 2), quien desarrolló el instrumento para evaluar la capacidad de los pacientes de utilizar los servicios sanitarios de forma oportuna y eficaz, sin hacer frente a barreras significativas.

El instrumento se encuentra constituido por 27 preguntas distribuidas en 4 dimensiones: geográfica, organizacional, sociocultural y económica. Cada pregunta reporta 5 opciones de respuesta tipo Likert: nunca 1 punto, rara vez 2 puntos, a veces 3 puntos, frecuentemente 4 puntos y siempre 5 puntos (Carrasco, 2024).

Así mismo, Carrasco (2024) categorizó la variable y las dimensiones en 3 niveles: bajo, medio y alto; sin embargo, no proporcionó información sobre las puntuaciones asociadas a cada categoría. Por esa razón, se asignará un puntaje a cada categoría y se calculará el rango de valores, tomando como referencia los percentiles 50 y 75.

Variable acceso en salud:	Bajo (<68 puntos / <P ₅₀) Medio (68-102 puntos / P ₅₀ -P ₇₅) Alto (>102 puntos / >P ₇₅)
Dimensión geográfica:	Bajo (<11 puntos / <P ₅₀) Medio (11-16 puntos / P ₅₀ -P ₇₅) Alto (>16 puntos / >P ₇₅)
Dimensión organizacional:	Bajo (<23 puntos / <P ₅₀) Medio (23-35 puntos / P ₅₀ -P ₇₅) Alto (>35 puntos / >P ₇₅)
Dimensión sociocultural:	Bajo (<21 puntos / <P ₅₀) Medio (21-31 puntos / P ₅₀ -P ₇₅) Alto (>31 puntos / >P ₇₅)
Dimensión económica:	Bajo (<16 puntos / <P ₅₀) Medio (16-23 puntos / P ₅₀ -P ₇₅) Alto (>23 puntos / >P ₇₅)

Validez y confiabilidad

Carrasco (2024), en Lambayeque-Perú, reportó que el instrumento es válido y confiable, pues al someterlo a un proceso de juicio de expertos, la mayoría de especialistas coincidió de manera cualitativa que era aplicable, identificando correlaciones entre los elementos entre 0.184 a 0.777. Además, obtuvo un alfa de Cronbach de 0,867, lo que indica una alta consistencia interna.

3.4.3 Sección III: Calidad de vida

Esta variable se medirá con el cuestionario de calidad de vida WHOQOL BREF de la OMS (Anexo 2), creado en 1995 para evaluar la percepción de las personas sobre su bienestar

y satisfacción en diferentes aspectos de su vida, sin importar las diferencias culturales (Cutipa y Zamora, 2020).

El cuestionario se encuentra constituido por 26 preguntas, distribuidas en 4 dimensiones: salud física, salud psicológica, relaciones sociales y ambiente. Cada pregunta posee 5 opciones de respuesta tipo Likert, que varían en base al contenido específico de la interrogante (Cutipa y Zamora, 2020).

La puntuación total y por dimensiones se obtiene sumando los valores obtenidos en cada interrogante. A continuación, se presenta la categorización propuesta por la OMS (Arias y Espeza, 2022):

Variable calidad de vida:	Baja (0-30 puntos)
	Moderada (31-69 puntos)
	Alta (70-100 puntos)
Salud física:	Baja (6-14 puntos)
	Moderada (15-25 puntos)
	Alta (36-35 puntos)
Salud psicológica:	Baja (6-14 puntos)
	Moderada (15-23 puntos)
	Alta (24-30 puntos)
Relaciones sociales:	Baja (3-6 puntos)
	Moderada (7-10 puntos)
	Alta (11-15 puntos)
Ambiente:	Baja (8-18 puntos)
	Moderada (19-28 puntos)
	Alta (29-30 puntos)

Validez y confiabilidad

Este instrumento ha sido validado en el contexto peruano por Cutipa y Zamora (2020), en una muestra de 203 pobladores entre 18 y 55 años. Los autores concluyeron que el cuestionario es válido, pues todos los especialistas indicaron de manera cualitativa que es aplicable en el proceso de juicio de expertos. Además, se hallaron resultados de V de Aiken

mayores de 0.70, lo que sugiere que la mayoría de ítems son adecuados. En cuanto a su confiabilidad se encontró un coeficiente de alfa de Cronbach que fluctuó entre 0,70 y 0,87 y un coeficiente de Omega que varió entre 0,72 y 0,82, valores que indicarían niveles óptimos de confiabilidad.

3.5. Procedimientos

Se solicitará la revisión y aprobación del proyecto de investigación a la Universidad Nacional Federico Villarreal y a la Unidad de Docencia e Investigación de la Dirección de Redes Integrales de Salud (DIRIS) Lima Centro. Así mismo, se ingresará por mesa de partes de la DIRIS una solicitud de autorización para ejecutar el estudio en las instalaciones del Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca.

Luego, se socializarán los documentos con el jefe del Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, para delimitar a la población en estudio y pactar las fechas y horas de recolección de datos.

La recabación de información se llevará a cabo en un periodo de 5 meses (abril-agosto). Para ello, el investigador asistirá 3 veces por semana al establecimiento en el horario matutino.

El primer contacto con el paciente se llevará a cabo en consultorio externo, antes de que culmine la consulta médica. En ese momento, se invitará al paciente a participar en el estudio, previa explicación de los objetivos, procedimientos, beneficios y riesgos. Todos aquellos que decidan colaborar con la investigación, deberán firmar una hoja de consentimiento informado (Anexo 3) y serán trasladados a otro ambiente para proceder con el llenado del cuestionario (Anexo 2).

La información consignada en el instrumento será vaciada a un software estadístico, para proceder con su análisis descriptivo e inferencial.

3.6. Análisis de datos

Se empleará el software estadístico SPSS versión 25 para construir la base de datos, implementando un control de calidad riguroso durante la entrada de información. Esto implicará seleccionar registros que cumplan con los criterios definidos y puedan ser clasificados de manera adecuada, optimizando así el posterior análisis estadístico.

3.6.1 Análisis descriptivo

Se analizarán variables tanto cualitativas como cuantitativas. Para las variables cualitativas, se calcularán frecuencias absolutas (n) y frecuencias relativas (%), mientras que, para las variables cuantitativas, se utilizarán medidas de tendencia central (como la media o la mediana) y medidas de dispersión (como la desviación estándar o el rango).

3.6.2 Análisis bivariado

Para determinar la relación entre el acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca. Se utilizará la correlación de Spearman para evaluar la relación entre las variables, analizando el coeficiente de correlación (Rho). Un resultado se considerará estadísticamente significativo si el p-valor es menor a 0.05, lo que indicará la presencia de una correlación significativa entre las variables estudiadas.

3.6.3 Análisis multivariado

Se empleará una regresión de Poisson con varianza robusta (RPa) para determinar la relación entre el acceso en salud y la calidad de vida, ajustada a variables sociodemográficas y clínicas en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, ajustada a variables sociodemográficas y clínicas en pacientes con patología, la significancia se fijará en un 5%.

Al concluir los resultados se organizarán en tablas simples y de doble entrada, y serán representadas mediante gráficos.

3.7. Consideraciones éticas

Este estudio contará con la revisión y aprobación del comité de ética de la Universidad Nacional Federico Villarreal y de la Unidad de Docencia e Investigación de la DIRIS Lima Centro. Estas entidades velarán por el cumplimiento de las normas y leyes que regulan la ética en investigación, evitando todo tipo de plagio y respetando el principio de propiedad intelectual.

Así mismo, se cumplirá con los principios éticos propuestos por la Asociación Médica Mundial en la Declaración de Helsinki:

Beneficencia: La presente investigación permitirá mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de los usuarios externos en condición de referidos; además facilitará la sensibilización y concientización sobre la importancia de la salud mental e incrementará la colaboración intersectorial.

No maleficencia: No se incurrirá en daño, ya que solo se solicitará el llenado de un cuestionario.

Autonomía: Se llevará a cabo el proceso de consentimiento informado (Anexo 3), para garantizar la participación libre y voluntaria de los usuarios externos en condición de referidos.

Justicia: El investigador ofrecerá a cada usuario externo las mismas posibilidades de participar en el estudio, independientemente de su condición social, etnia o género.

El cuestionario será codificado para mantener el anonimato de los participantes y se cifrarán en una carpeta, para evitar el acceso no autorizado y la divulgación de información sin fines científicos.

IV. Aspectos administrativos

4.1. Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mar	2025 Abr- Ago	Sep	Oct	Nov
Revisión bibliográfica	X						
Elaboración del proyecto	X	X					
Revisión del proyecto		X					
Presentación ante autoridades			X				
Revisión de instrumentos			X				
Preparación del material de trabajo			X				
Selección de la muestra				X			
Recolección de datos				X			
Control de calidad de datos					X		
Análisis e interpretación					X		
Redacción informe final					X	X	
Impresión del informe final							X

4.2. Presupuesto de la investigación

RECURSOS	Nº	C.U.	TOTAL
- Asesor de investigación	1	S/. 500.00	S/. 500.00
- Asesor estadístico	1	S/. 500.00	S/. 500.00
- Materiales de escritorio	-	S/. 250.00	S/. 250.00
- Hoja bond A4.	2 millares	S/. 25.00	S/. 50.00
- Fólderes	3	S/. 10.00	S/. 30.00
- Archivadores	2	S/. 10.00	S/. 20.00
- Internet	-	-	S/. 180.00
- Fotocopias	1500	S/. 0.10	S/. 150.00
- Anillado y empastado	-	-	S/. 210.00
- Otros gastos	-	-	S/. 450.00
Total			S/. 2340.00

4.3. Fuentes de financiamiento

Autofinanciamiento

V. Referencias

- Adusei, P., y Adjei, M. (2023). Social capital, access to healthcare, and health-relates quality of life in urban Ghana. *Journal of Urban Affairs*, 45(3). <https://doi.org/10.1080/07352166.2021.1969245>
- Al Sayigh, N., Mahmoud, M., Ali, A., Fouad, G., Amer, F., y Husain, Z. (2023). Health-Related Quality of Life and Service Barriers among Adults with Sickle Cell Disease in Saudi Arabia. *Ethiop J Health Sci*, 33(1), 831-40. <https://doi.org/10.4314/ejhs.v33i5.13>
- Alexandrov, N., Scott, E., Janssen, M., Lubetkin, E., Yfantopoulos, J., Bonsel, G., y Haagsma, J. (2024). The relationship between healthcare access and change in health-related quality-of-life among the general population of five countries during the COVID-19 pandemic. *Quality of Life Research*, 33(1), 2541-52. <https://doi.org/10.1007/s11136-024-03704-1>
- Ann, R., Lancia, S., Cutter, G., Fox, R., y Salter, A. (2024). Access to Care and Health-Related Quality of Life in Multiple Sclerosis. *Neurology Clinical Practice*, 14 (6), 1-12. <https://doi.org/10.1212/CPJ.0000000000200338>
- Arias, Y., y Espeza, Y. (2022). *Calidad de vida en adultos mayores durante la pandemia por Covid – 19 de una población vulnerable del distrito de Cerro Azul, Cañete - 2022*. [Tesis de Grado, Universidad de Ciencias y Humanidades]. Repositorio Institucional UCH. https://repositorio.uch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12872/756/Arias_YS_Espeza_Y_tesis_enfermeria_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Bazualdo, E., y Contreras, R. (2022). La importancia de las Barreras de acceso y equidad en la. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 973-98. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3590

- Bogart, K., Hemmesch, A., Barnes, E., Blissenbach, T., Beisang, A., y Engel, P. (2022). Healthcare access, satisfaction, and health-related quality of life among children and adults with rare diseases. *Orphanet J Rare Dis*, 17(1), 1-15. <https://doi.org/10.1186/s13023-022-02343-4>
- Carandang, R., Olea, A., Legaspi, P., Quimen, Y., Ebrada, M., y Miranda, K. (2024). Health Care Access and Quality of Life of Community-Dwelling Senior Citizens in Pampanga, Philippines. *Sage Open Aging*, 10(1), 1-10. <https://doi.org/10.1177/23337214241280851>
- Carrasco, J. (2024). *Gasto de bolsillo y acceso a los servicios de salud en pacientes afiliados a un establecimiento de salud, Lambayeque-Perú 2024*. [Tesis de Mestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/156094/Carrasco_PJH-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Castillo, I. (2024). *Acceso a los servicios de salud y calidad de vida en pacientes con discapacidad de un hospital de Cajamarca, 2024* [Tesis de posgrado. Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/151389>
- Coombs, N., Meriwether, W., Caringi, J., y Newcomer, S. (2021). Barriers to healthcare access among U.S. adults with mental health challenges: A population-based study. *SSM Popul Health*, 1(1), 10-15. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100847>
- Cutipa, L., y Zamora, K. (2020). *Adaptación y Traducción del Cuestionario WHOQOL - BREF de Calidad de Vida en Adultos de la Sierra Peruana*. [Tesis de Grado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/50917/Cutipa_NLM%20-%20Zamora_GKJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Choojatur, S., Sindhu, S., Utriyaprasit, K., y Viwatwongkasem, C. (2019). Factors associated with access to health services and quality of life in knee osteoarthritis patients: a multilevel cross-sectional study. *BMC Health Services Research*, 19(688), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4441-2>
- De Tapia, J., Encina, R., Piangatelli, M., Pirola, J., González, G., y Moscoso, N. (2024). Barreras al acceso según las etapas del proceso de atención de la salud de los adultos mayores. *Gerokomos*, 34(3), 183-7. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2023000300006.
- Defensoría del pueblo. (2024). *Acceso a la salud*. https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/acceso-a-la-salud/
- Erskine, N., Gandek, B., Tran, H., Abu, H., McManus, D., Kiefe, C., y Goldberg, R. (2019). Barriers to Healthcare Access and to Improvements in Health-Related Quality of Life After an Acute Coronary Syndrome (From TRACE-CORE). *Am J Cardiol*, 122(7), 1121-1127. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2018.06.043>
- Gobierno del Perú. (2024). *Derechos de las personas usuarias de los servicios de salud* . <https://www.gob.pe/10423-derechos-de-las-personas-usuarias-de-los-servicios-de-salud>
- Goes, M., Lopes, M., Maroco, J., Oliveira, H., y Fonseca, C. (2021). Psychometric properties of the WHOQOL-BREF(PT) in a sample of elderly citizens. *Health Qual Life Outcomes*, 19(1), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12955-021-01783-z>
- Hernández, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2da ed.). México D.F.: Mc Graw Hill Education.
- Houghton, N., Báscolo, E., Jara, L., Cuellar, C., Coitiño, A., Del Riego, A., y Ventura, E. (2022). Barreras de acceso a los servicios de salud para mujeres, niños y niñas en

América Latina. *Rev Panam Salud Publica*, 46(1), 1-9.

<https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.94>

Levesque, J., Harris, M., y Russell, G. (2013). Patient-centred access to health care: conceptualising access at the interface of health systems and populations. *International Journal for Equity in Health*, 12(1), 1-9.
<http://www.equityhealthj.com/content/12/1/18>.

Ministerio de Salud [MINSA]. (2024). *Minsa fortalece el acceso a servicios de salud a través de la telemedicina mediante la aprobación de nuevas normativas*.
<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/954169-minsa-fortalece-el-acceso-a-servicios-de-salud-a-traves-de-la-telemedicina-mediante-la-aprobacion-de-nuevas-normativas>

Moroz, N., Moroz, I., y D Angelo, M. (2020). Mental health services in Canada: Barriers and cost-effective solutions to increase access. *Healthcare Management Forum*, 33(6), 1-15. <https://doi.org/10.1177/0840470420933911>

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2022). *WHO highlights urgent need to transform mental health and mental health care*. <https://www.who.int/news/item/17-06-2022-who-highlights-urgent-need-to-transform-mental-health-and-mental-health-care>

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). *Derechos humanos*.
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health>

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2023). *Analizar y superar las barreras de acceso para fortalecer la atención primaria de salud*. OPS.
<https://iris.paho.org/handle/10665.2/57803>

Ortiz, P., y Martínez, C. (2021). Influencia del profesional de enfermería en la calidad de vida de pacientes receptores de trasplante renal. *Rev. Esp. Salud Publica*, 95(7), 1-13.
<https://www.scielosp.org/article/resp/2021.v95/e202107093/>.

- Osongo, S., Mactaggart, I., Godia, P., Davey, C., y Olenja, J. (2024). A Comparative Study of Access to Healthcare and Health-Related Quality of Life among Adults with Disabilities during COVID-19 Pandemic in Kakamega County, Kenya. *Afr. J. Health Sci*, 37(1), 33-42. <https://doi.org/10.4314/ajhs.v37i1.4>
- Pezo, O., Peñaloza, U., y Pezo, J. (2023). Diagnóstico del acceso a servicios de salud gineco-obstetra de las mujeres internas en establecimientos penitenciarios del Perú. *Med. clín. soc*, 7(2), 113-18. <https://doi.org/10.52379/mcs.v7i2.276>
- Ramírez-Coronel, A., Malo-Larrea, A., Martínez-Suarez, P., Montánchez-Torres, M., Torracchi-Carrasco, E., y González-León, F. (2020). Origen, evolución e investigaciones sobre la Calidad de Vida: Revisión Sistemática. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 39(8), 954-59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4543649>
- Rivera-Lozada, O., Rivera-Lozada, I., y Bonilla-Asalde, C. (2020). Determinantes del acceso a los servicios de salud y adherencia al tratamiento de la tuberculosis. *Revista Cubana de Salud Pública*, 46(4), 1-19. <https://revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/1990>.
- Robledo, C., Duque, C., Hernández, J., Ruiz, M., y Zapata, R. (2022). Envejecimiento, calidad de vida y políticas públicas en torno al envejecimiento y la vejez. *Rev.ces derecho*, 13(2), 10-17. <https://doi.org/10.21615/cesder.6453>
- Royce, R., Dreyko, A., Kaila, P., Quimen, Y., Niña, M., y Jace, K (2024). Health Care Access and Quality of Life of Community-Dwelling Senior Citizens in Pampanga, Philippines. *Gerontol Geriatr Med*, 10(1), 1-15. <https://doi.org/10.1177/23337214241280851>
- Ruíz-Prieto, D., y López-Medina, I. (2023). Calidad de vida relacionada con la salud y afectación física en personas con lesiones por presión. *Gerokomos*, 33(3), 1-6.

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2022000300011.

- Vértiz-Ramírez, J., Ramírez-Palacios, P., Ríos-Cázares, G., Sánchez-Domínguez, M., Ochoa-Torres, M., De Negri-Filho, A., y Saturno-Hernández, P. (2024). Vulnerabilidad y barreras de acceso a los servicios de salud *Salud Publica Mex*, 66(1), 556-70. <https://doi.org/10.21149/16199>
- Wang, Y., Wu, Y., Chu, H., Xu, Z. S., y Fang, H. (2023). Association between Health-Related Quality of Life and Access to Chronic Disease Management by Primary Care Facilities in Mainland China: A Cross-Sectional Study. *Int J Environ Res Public Health*, 20(5), 10-17. <https://doi.org/10.3390/ijerph20054288>
- Ypanaque, J. (2024). Barreras de acceso a los servicios primarios de salud sexual y reproductiva en adolescentes, de una comunidad urbano marginal del Perú. *Med. clín. soc*, 8(1), 35-39. <https://doi.org/10.52379/mcs.v8i1.329>
- Zhang, T., Liu, C., Ni, Z. (2019). Association of Access to Healthcare with Self-Assessed Health and Quality of Life among Old Adults with Chronic Disease in China: Urban Versus Rural Population. *Int J Environ Res Public Health*, 16(14),1-14. <https://doi.org/10.3390/ijerph16142592>

VI. Anexos

Anexo 1. Matriz de consistencia

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología
Problema general ¿Cuál es la relación entre el acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025? Problemas específicos ¿Cuál es la relación entre la dimensión geográfica del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025? ¿Cuál es la relación entre la dimensión organizacional del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025? ¿Cuál es la relación entre la dimensión sociocultural del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025? ¿Cuál es la relación entre la dimensión económica del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025? ¿Cuál es la relación entre el acceso en salud y la calidad de vida, ajustada a variables sociodemográficas y clínicas en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025?	Objetivo general Relacionar el acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025. Objetivos específicos Identificar la relación entre la dimensión geográfica del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025. Identificar la relación entre la dimensión organizacional del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025. Identificar la relación entre la dimensión sociocultural del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025. Identificar la relación entre la dimensión económica del acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025.	Hi: La relación entre el acceso en salud y la calidad de vida es directa y significativa en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025. Ho: La relación entre el acceso en salud y la calidad de vida no es directa y significativa en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025	Variable 1: Acceso en salud Variable 2: Calidad de vida Variables intervinientes: Edad Sexo Estado civil Grado de instrucción Procedencia Condición laboral Ingresos económicos Condición de fumador Trastornos psicológicos o psiquiátricos Comorbilidades médicas	Tipo de investigación: Observacional, correlacional y transversal. Población de estudio: 250 usuarios externos referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, durante el periodo abril-agosto del 2025. Muestra: 152 usuarios Técnica de recolección de datos: Encuesta. Instrumento: Cuestionario para medir el acceso a la salud. Cuestionario de calidad de vida WHOQOL BREF Análisis de datos: Frecuencias relativas y absolutas. Medidas de tendencia central y dispersión. Rho de Spearman, Regresión de Poisson con varianza robusta.

Ninguna ()
 Hipertensión arterial ()
 Diabetes mellitus ()
 Enfermedad cardíaca ()
 Otras: _____

Sección II: Acceso en salud

Cuestionario para medir el acceso en salud

Dimensión Geográfica		1 Nunca	2 Rara vez	3 A veces	4 Frecuentemente	5 Siempre
1	¿El establecimiento de salud se encuentra cerca de su vivienda?					
2	¿Le es fácil llegar desde su domicilio al establecimiento de salud?					
3	¿Tiene facilidad para conseguir un medio de transporte que lo lleve al establecimiento de salud?					
4	¿Le es fácil encontrar transporte público?					
Dimensión Organizacional		1 Nunca	2 Rara vez	3 A veces	4 Frecuentemente	5 Siempre
5	¿Considera Ud. que la atención recibida es buena?					
6	¿El seguro cubre todos los tratamientos que usted necesita actualmente?					
7	¿Considera usted que los trámites administrativos para ser atendido fueron sencillos?					
8	¿El tiempo de espera le pareció adecuado?					
9	¿Los horarios de atención son adecuados?					
10	¿Considera que el establecimiento de salud cuenta con la infraestructura necesaria?					
11	¿El establecimiento de salud cuenta con los equipos necesarios para atender sus necesidades?					
12	¿La farmacia cuenta con todos los medicamentos que le han recetado?					
13	¿El establecimiento de salud cuenta con el personal suficiente?					

Dimensión Sociocultural		1 Nunca	2 Rara vez	3 A veces	4 Frecuentemente	5 Siempre
14	¿Se siente tranquilo cuando se atiende en el establecimiento de salud?					
15	¿Considera que el personal de salud se encuentra capacitado para brindarle la atención adecuada?					
16	¿Confía en que el tratamiento recibido será efectivo?					
17	¿Considera que el personal le brinda un buen trato?					
18	¿Durante la atención no se ha sentido vulnerado en sus creencias y costumbres?					
19	¿Siente que el personal de salud se preocupó por atender su problema de salud?					
20	¿Recibe información sobre su salud y/o tratamiento de manera que pueda entenderla completamente?					
21	¿Ha tenido alguna experiencia en la que se haya sentido incomprendido/a o discriminado/a debido a su origen social o cultural?					
Dimensión Económica		1 Nunca	2 Rara vez	3 A veces	4 Frecuentemente	5 Siempre
22	¿Gasta poco dinero al trasladarse al establecimiento de salud?					
23	¿Puede costear los gastos para acudir a consulta?					
24	¿Cuenta con el dinero suficiente para afrontar un gasto extra?					
25	¿Usted y/o su acompañante no tienen que dejar de trabajar para acudir a consulta?					
26	¿Ha presentado dificultades económicas para acceder a la atención médica en este centro?					
27	¿Ha tenido que posponer o evitar la atención médica debido a preocupaciones sobre el costo?					

Sección III: Calidad de vida

Cuestionario de calidad de vida WHOQOL BREF

Instrucciones:

Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y haga un círculo en el número de la escala que represente mejor su opción de respuesta.

		Muy mala	Mala	Ni mala ni buena	Buena	Muy buena
1	¿Cómo calificaría su calidad de vida?	1	2	3	4	5

		Muy insatisfecho	Insatisfecho	Ni satisfecho ni insatisfecho	Satisfecho	Muy satisfecho
2	¿Cuán satisfecho está con su salud?	1	2	3	4	5

		Nada	Un poco	Moderadamente	Muchísimo	En cantidad extrema
3	¿Hasta qué punto siente que el dolor físico le impide hacer lo que necesita hacer?	1	2	3	4	5
4	¿Cuánto tratamiento médico necesita para desenvolverse en su vida diaria?	1	2	3	4	5
5	¿Cuánto disfruta la vida?	1	2	3	4	5
6	¿Hasta qué punto siente que su vida es significativa?	1	2	3	4	5

7	¿Puede concentrarse?	1	2	3	4	5
8	¿Se siente seguro con su entorno social?	1	2	3	4	5
9	¿Qué tan limpio e higiénico es el lugar donde vive?	1	2	3	4	5

		Nada	Un poco	Moderadamente	Muchísimo	En cantidad extrema
10	¿Tienes suficiente energía en su vida diaria?	1	2	3	4	5
11	¿Acepta su apariencia corporal?	1	2	3	4	5
12	¿Tiene suficiente dinero para satisfacer sus necesidades?	1	2	3	4	5
13	¿Dispone de la información que necesita en su vida diaria?	1	2	3	4	5
14	¿Realiza actividades recreativas con frecuencia?	1	2	3	4	5

		Muy mala	Mala	Ni mala ni buena	Buena	Muy buena
15	¿Qué tan bien puede movilizarse físicamente?	1	2	3	4	5

Las siguientes preguntas se refieren a que tan **bien o satisfecho** se sintió sobre varios aspectos de su vida en las **últimas dos semanas**:

		Muy insatisfecho	Insatisfecho	Ni satisfecho ni insatisfecho	Satisfecho	Muy satisfecho
--	--	------------------	--------------	-------------------------------	------------	----------------

16	¿Qué tan satisfecho esta con su capacidad para dormir?	1	2	3	4	5
17	¿Qué tan satisfecho esta con su capacidad de realizar actividades de la vida diaria?	1	2	3	4	5
18	¿Qué tan satisfecho esta con su capacidad de trabajo?	1	2	3	4	5
19	¿Qué tan satisfecho esta consigo mismo?	1	2	3	4	5
20	¿Qué tan satisfecho esta con sus relaciones personales?	1	2	3	4	5
21	¿Qué tan satisfecho esta con su vida sexual?	1	2	3	4	5
22	¿Qué tan satisfecho esta con el apoyo que recibe de sus amigos?	1	2	3	4	5
23	¿Qué tan satisfecho esta con las condiciones de su hogar?	1	2	3	4	5
24	¿Qué tan satisfecho esta con su acceso a los servicios de salud?	1	2	3	4	5
25	¿Qué tan satisfecho esta con su transporte?	1	2	3	4	5

Las siguientes preguntas se refieren a que tan frecuentemente ha experimentado o sentido ciertas cosas en las **últimas dos semanas**:

		Nunca	Raras veces	A veces	Con frecuencia	Siempre
26	¿Con que frecuencia tiene sentimientos negativos como tristeza, desesperación, ansiedad, depresión?	1	2	3	4	5

Gracias por su participación

Anexo 3. Consentimiento informado

Acceso en salud y su relación con la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025

Investigador: Dr. Harold Vílchez Lavado

A usted se le está invitando a participar en esta investigación. Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad de preguntar sobre cualquier aspecto, para posteriormente decidir con conocimiento de causa y plasmar su firma en este documento.

Objetivo de la investigación

Relacionar el acceso en salud y la calidad de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, 2025.

Beneficios de la investigación

Usted no pagará nada por participar en esta investigación y, tampoco, recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole. La ejecución de este trabajo permitirá mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de los usuarios externos en condición de referidos; además facilitará la sensibilización y concientización sobre la importancia de la salud mental e incrementará la colaboración intersectorial.

Procedimientos

En caso de aceptar participar en esta investigación se le solicitará el llenado de un cuestionario.

Riesgos

No existirán riesgos.

Aclaraciones

Su decisión de participar en la investigación es completamente voluntaria y no habrá ninguna consecuencia, en caso de no aceptar la invitación. Si decide participar puede

retirarse en el momento que lo desee, pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad. En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador responsable.

Confidencialidad

Se mantendrá la confidencialidad de los datos obtenidos y se guardará su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio fuesen publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de los participantes.

Consentimiento

Yo, _____ he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado(a) y entiendo que los datos obtenidos en la investigación pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar. Sé que si presentó dudas puedo comunicarme con el investigador.

Firma del participante: _____

Firma del investigador: _____

Fecha: _____

REVOCATORIA DEL CONSENTIMIENTO

Yo, _____ de
_____ años, identificado con DNI/CE N.º _____ revoco el consentimiento
prestado y no deseo proseguir con el estudio “Acceso en salud y su relación con la calidad
de vida en usuarios referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca,
2025” que desarrollará el Dr. Harold Vílchez de la Universidad Nacional Federico
Villarreal.

____/____/____

Fecha

Firma del Participante



Universidad Nacional
Federico Villarreal

EUPG
ESCUELA UNIVERSITARIA DE
POSGRADO

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Secretaría Académica

Lima, 14 de julio del 2025

CARTA N°021-2025-SA-EUPG-UNFV

Señor

PEDRO ALEJANDRO CRUZADO PUENTE

Director General

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Presente. -

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, para saludarla cordialmente, y a la vez presentarle al Sr. **VILCHEZ LAVADO HAROLD CLAESEN**, con D.N.I. 43633998 **EGRESADO** de la **Maestría en Gestión y Conducción en Salud** de esta Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Remitimos la presente, en virtud que el alumno antes mencionado se encuentra realizando trabajos de investigación, recopilando datos e información para desarrollar su Plan Tesis titulado: **"ACCESO EN SALUD Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA EN USUARIOS REFERIDOS AL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MANGOMARCA, 2025"**, por lo que, se requiere que su representada brinde las facilidades, y el apoyo necesario para la aplicación del mencionado trabajo, de esta manera pueda concluir con la investigación, **para Optar el Grado Académico de Maestro.**

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para, manifestarle mi saludo cordial.

Atentamente,

V° B°

DR. JUSTO PASTOR SOLIS PONSECA
DIRECTOR

DRA. ARMANDA TIRADO SENGIFO
SECRETARIA ACADÉMICA

NT. 051742-2025
Lander S.

Lima, 01 de agosto del 2025

Carta N° 042-CE-UIIE-EUPG-2024

Doctora

Eulalia Jurado Falconi

Jefe de la Unidad de Investigación, Innovación y Emprendimiento

Escuela Universitaria de postgrado

Universidad Nacional Federico Villarreal

Presente

Ref.: OFICIO N° 280-2025-UIIE-EUPG-UNFV

De mi mayor consideración:

Saludándola cordialmente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que, en Sesión del Comité de Ética de la Escuela Universitaria de Post Grado el día de hoy con la asistencia en pleno de los miembros se acordó emitir opinión FAVORABLE al Plan de Tesis "ACCESO EN SALUD Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA EN USUARIOS REFERIDOS AL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MANGOMARCA, 2025", del egresado VILCHEZ LAVADO HAROLD CLAESEN, para optar el Grado Académico de Maestro en Gestión y Conducción en Salud.

Es lo que informo a usted para los fines consiguientes.

Agradezco la atención a la presente, hago propicia la oportunidad para reiterarle mis consideraciones y aprecio personal.



Dra. Gloria Cruz Gonzales
Presidente del Comité de Ética

Adjunto: Acta de Evaluación N°042-2025 del Comité de Ética



Universidad Nacional
Federico Villarreal

EUPG
ESCUELA UNIVERSITARIA DE
POSGRADO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA N° 042 -2025-UIIE-EUPG-UNFV
EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA

Siendo las 18 horas del día 01 de Agosto del 2025, los miembros del Comité de Ética de la Unidad de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Escuela de Post grado, integrado por la Dra. Gloria Esperanza Cruz Gonzáles, en calidad de Presidenta, la Dra. Martha Gonzales Loli en calidad de Secretaria; y los miembros Dra. Catalina Bello Vidal, Dr. Franco Raúl Mauricio Valentín, Mg. Wilder Moreno López, se reúnen virtualmente ante la solicitud plasmada en el Formato Único de Trámite solicita con NT: 51743 - 2025, presentado por el egresado VILCHEZ LAVADO HAROLD CLAESEN, quien solicita la aprobación por el Comité de Ética de nuestra Casa Superior de Estudios, para su proyecto de Tesis titulado: "ACCESO EN SALUD Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA EN USUARIOS REFERIDOS AL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MANGOMARCA, 2025", el tamaño de la muestra son 250 usuarios externos referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Mangamarca, durante el periodo abril-agosto del 2025,. El Comité de Ética de la Unidad de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Escuela de Post grado, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por nuestra Universidad, brinda su APROBACIÓN, considerando que el trabajo cumple los lineamientos establecidos para que pueda continuar su desarrollo.

El dictamen se sustenta en los artículos 50º, 51º, 52º, 53º y 54º del Reglamento de Investigación (Resolución R. N° 7898-2004-UNFV del 25 de febrero de 2004), que se refleja en el siguiente protocolo:

Nº	TÍTULO DEL PLAN DE TESIS	INVESTIGADOR	OPINIÓN
01	"ACCESO EN SALUD Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA EN USUARIOS REFERIDOS AL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MANGOMARCA, 2025"	VILCHEZ LAVADO HAROLD CLAESEN	FAVORABLE

Siendo las veinte horas del día mencionado, los miembros del Comité de Ética suscribimos el presente documento:


Dra. Gloria Esperanza Cruz Gonzales
Presidenta
Comité de Ética


Dra. Martha Gonzales Loli
Miembro
Comité Científico


Dra. Catalina Bello Vidal
Miembro
Comité de Ética


Dr. Franco Raúl Mauricio Valentín
Miembro
Comité de Ética


Mg. Wilder Moreno López
Miembro
Comité de Ética